Jonathan Loyarte : “Prévenir les risques psychosociaux, c’est aussi gouverner autrement le travail public”

Par **Marie Malaterre** - 8 septembre 2026 - 7 min de lecture

Épuisement, perte de sens et fragilisation des collectifs : la souffrance psychique dans la fonction publique révèle moins un problème individuel qu'une crise des conditions de travail, selon l'analyse de Jonathan Loyarte, fondateur de l'Observatoire des RPS dans la fonction publique et chef de projet Qualité de vie au travail à la ville de Marseille. Selon lui, la prévention ne peut plus se limiter à accompagner les agents en difficulté. Elle doit interroger les organisations, leurs transformations et leur capacité à permettre à chacun de bien faire son métier.



Jonathan Loyarte, fondateur de l'Observatoire des RPS dans la fonction publique et chef de projet Qualité de vie au travail à la ville de Marseille.

La souffrance psychique au travail dans la fonction publique est désormais difficile à considérer comme un phénomène périphérique. Épuisement professionnel, perte de sens, conflits de valeurs, difficultés de recrutement et de fidélisation, fragilisation des collectifs : les signaux s’accumulent.

Les travaux de la mission d’information sénatoriale consacrés à la souffrance au travail, qui n’ont pas été rendus publics, ont eu, à cet égard, un mérite essentiel : celui de déplacer le regard. Car derrière la question de la souffrance apparaît progressivement une autre question, peut-être plus fondamentale encore : celle du travail et de la manière dont nous le gouvernons.

C’est probablement là que se situe aujourd’hui l’un des principaux enjeux de la prévention dans la fonction publique. Depuis plusieurs années, les employeurs publics développent des dispositifs destinés à mieux prendre en charge les difficultés rencontrées par les agents : cellules d’écoute, soutien psychologique, sensibilisation, formation, accompagnement individuel ou dispositifs de signalement. Ces réponses sont nécessaires. Mais elles interviennent souvent lorsque les difficultés sont déjà constituées.

Or, les enseignements des auditions sénatoriales convergent sur un point : une partie importante des difficultés trouve son origine en amont, dans les conditions mêmes d’exercice du travail. Intensification des contraintes, succession des transformations, réduction des marges de manœuvre, fragilisation des collectifs, multiplication des injonctions contradictoires, perte de sens ou conflits de valeurs constituent autant de facteurs susceptibles d’altérer durablement la santé des agents.

Dès lors, une question devrait davantage guider nos politiques de prévention. Au lieu de nous demander seulement comment accompagner les agents lorsqu'ils ne peuvent plus tenir, demandons-nous ce qui, dans le travail, les oblige progressivement à tenir au prix de leur santé. Ce déplacement est essentiel. Il conduit à passer d'une prévention principalement centrée sur les personnes à une prévention qui interroge aussi l'organisation.

Le véritable sujet est peut-être le travail empêché

Les agents publics ne sont pas uniquement confrontés à une quantité de travail. Ils doivent quotidiennement composer avec des prescriptions, des procédures, des objectifs, des indicateurs et des contraintes qu'ils adaptent à la réalité des situations, aux besoins des usagers, aux moyens disponibles et aux exigences de leur métier. C'est précisément dans cet écart entre le travail prescrit et le travail réel que se construit une grande partie du service public. Mais les difficultés apparaissent lorsque cet écart devient impossible à réguler.

Lorsque les agents ne disposent plus du temps, des moyens, de l'autonomie ou des coopérations nécessaires pour réaliser un travail qu'ils considèrent comme professionnellement acceptable, ce n'est plus seulement la charge qui est en cause. C'est la possibilité même de bien faire son travail. Les auditions de la mission sénatoriale caractérisent ainsi ce que les sciences du travail désignent depuis longtemps comme le travail empêché : non pas seulement la fatigue liée à l'effort, mais celle qui naît de l'impossibilité de réaliser son métier conformément aux exigences que l'on place en lui. Cette distinction devrait modifier profondément notre manière d'aborder les risques psychosociaux.

Une réorganisation, une mutualisation, une réduction de moyens, une transformation numérique, une modification des objectifs ou des circuits de décision sont généralement examinées sous leurs dimensions juridique, financière, technique ou opérationnelle. Mais beaucoup plus rarement à partir d'une question simple : que va changer cette décision dans le travail de ceux qui devront la mettre en œuvre ?

Pourtant, une décision peut augmenter ou réduire les marges de manœuvre ; renforcer ou fragiliser un collectif ; faciliter ou compliquer les coopérations ; rendre le travail plus intelligible ou multiplier les contradictions ; préserver le sens du métier ou l'altérer. Autrement dit, les décisions organisationnelles produisent des effets sur les conditions de travail et peuvent, à ce titre, produire des effets sur la santé.

Cette dimension reste encore insuffisamment intégrée au processus de décision. Évaluer leur soutenabilité humaine ne devrait pas intervenir lorsque les difficultés apparaissent. Cela devrait constituer l'une des dimensions de leur conception. Parler de "gouvernance du travail" peut susciter un malentendu. Il ne s'agit évidemment pas d'ajouter du contrôle au contrôle, des indicateurs aux indicateurs ou des procédures aux procédures.

Gouverner le travail ne signifie pas gouverner davantage les travailleurs

Cela signifie créer les conditions permettant aux professionnels d'exercer leurs compétences, de coopérer, de disposer de marges d'initiative, de discuter des difficultés rencontrées et de participer à la régulation du travail réel. Cela suppose également de reconnaître une fonction essentielle de la gestion publique : celle de la régulation.

Le manager ne peut pas seulement être celui qui décline des objectifs et contrôle leur réalisation. Il doit pouvoir arbitrer des contradictions, organiser la coopération, faire remonter les difficultés du terrain et disposer lui-même d'un pouvoir d'agir suffisant pour les traiter. Encore faut-il que l'organisation lui en donne les moyens. Faire peser sur les managers la responsabilité de la santé des équipes sans interroger les objectifs, les moyens et les arbitrages auxquels ils sont soumis reviendrait simplement à déplacer la responsabilité. Il faut également prendre au sérieux ce que nous disent les conflits de valeurs.

Lorsqu'un agent considère qu'il ne peut plus rendre le service qu'il doit rendre, lorsqu'un professionnel doit régulièrement agir contrairement aux règles de métier qu'il juge nécessaires ou lorsqu'un cadre doit porter des décisions qu'il ne parvient plus à rendre intelligibles auprès de ses équipes, nous ne sommes pas seulement face à des perceptions individuelles. Ces situations nous éclairent sur le fonctionnement de l'organisation.

Les conflits de valeurs peuvent ainsi être privilégiés comme de véritables signaux de santé organisationnelle. La mission sénatoriale ouvre sur ce point une perspective particulièrement importante. Une organisation capable de les entendre peut les transformer en matière à discussion et en capacité de régulation. Une organisation qui les individualise ou les ignore risque au contraire de transformer progressivement des contradictions organisationnelles en difficultés humaines.

Réformer avec les agents ne signifie pas seulement les consulter

Cette approche conduit également à reconsidérer la place du dialogue professionnel dans les transformations publiques. La consultation est nécessaire, mais elle ne suffit pas. Réformer avec les agents ne signifie pas seulement les consulter. Cela signifie organiser la possibilité que ce qu'ils disent du travail puisse modifier la décision. Les espaces de discussion sur le travail prennent alors une fonction stratégique. Ils ne sont pas seulement des espaces d'expression. Ils permettent d'identifier les difficultés, de confronter le prescrit au réel, de repérer les contradictions, d'ajuster les organisations et de construire des arbitrages. Ils constituent, à ce titre, un instrument de prévention primaire.

C'est finalement le principal enseignement que l'on peut tirer de ces travaux. Lorsqu'une administration connaît durablement une multiplication des alertes, des conflits de valeurs, des difficultés de coopération, une perte de confiance, des situations d'épuisement ou une dégradation des collectifs, elle ne révèle pas seulement un problème de santé au travail. Elle nous dit quelque chose de son fonctionnement.

Les risques psychosociaux peuvent ainsi être regardés non seulement comme des risques à prévenir, mais comme des indicateurs de la qualité de la gouvernance du travail. Cette perspective conduit à une ambition plus grande. Nous savons aujourd'hui organiser une gouvernance budgétaire, financière, numérique, environnementale ou encore une gouvernance des données. Il nous reste peut-être à reconnaître pleinement une autre dimension : la gouvernance du travail.

Cela signifie remettre le travail réel au cœur des décisions, examiner les conséquences humaines des transformations, préserver les capacités de régulation, donner aux managers un véritable pouvoir d'arbitrage et considérer la qualité du travail comme une dimension de la performance publique. Car la santé des agents et la qualité du service public ne constituent pas deux objectifs concurrents. Elles sont étroitement liées.

Une organisation qui permet durablement à ses agents de bien travailler protège leur santé, mais elle protège aussi ses compétences, ses collectifs, sa capacité d'adaptation et, finalement, la qualité du service rendu aux citoyens. La prévention des risques psychosociaux ne devrait donc plus être seulement une politique destinée à réparer les conséquences du travail. Elle peut devenir un principe de bonne gouvernance du travail public et, à ce titre, l'un des leviers de sa transformation durable.